胸腔科病房工作規範

1. 除一樓全院或內科部 meeting 外，7:30 請準時於 9C 病房會議室參加 morning meeting。科內學術活動請務必準時參加。
2. 病歷需準時完成。重要檢查、抗生素使用、化療、放射治療及其他重要事項，請紀錄於 TPR sheet 上。每週五固定打 weekly summary，每天要寫 VS comment, critical case 記得要點電子交班, 不穩定病人請主動與 CR 電話交班。
3. 每半個月有病歷評核一次, 包括一本 admission note 及一周的 progress note, weekly summary。在月中和月底收到評分後，記得填寫線上回饋意見。
4. 因應醫院推行檢驗分流，隔日抽血醫囑請減少開立 stat order, 若明日出院可於前一天下午先抽血
5. R, PGY 需幫忙同一大組(A, I, O)中其他 NSP team 的死診開立
6. 預期即將出院的病人請開立“**今辦明結**”,當日辦理出院請於早上 10:00 前開立出院醫囑
7. CPCR 後請於醫囑系統中登錄急救時間,原因，末期及癌症病人，請向家屬說明填寫末期醫療說明書
8. 病情不穩定或病情極具變化，需要 CR 幫忙時，請 call 病房 CR。主治醫師有病人要轉 ICU 時，請聯絡病房 CR。
9. Invasive procedure 若不熟或沒把握，請通知病房 CR 幫忙。
10. 照顧病人注意事項：
    - Acute respiratory failure 病人，請記載當時狀況、intubation indication 及 type of respiratory failure (hypoxemia/hypercapnia/mixed type)。
    - 對於氣喘的病人，請先評估病人，勿 routine 使用 Atrovent 加 Bricanyl inhalation，有需要者再開立。隨時監測 ABG 或 pulse oximeter，並紀錄當時的 FiO_2。
    - COPD、chronic asthma、bronchietctasis 及其他易在較高氧氣濃度下，容易發生 hypoventilation 而 CO_2 retention 的病人，需小心使用氧氣。
    - 易併發 hypoventilation 的病人，盡量避免使用安眠藥或鎮靜藥，需要的請特別小心使用。
    - 有肺部感染而使用抗生素者，請務必留過 smear 及 culture。抗生素使用，請依 ATS guideline。
    - 有使用 theophylline 或 amiophylline 的病人，請注意 overdose 之症狀 (nausea/vomiting/arrhythmia)。
      若有 active peptic ulcer bleeding，建議停用 theophylline。
11. Chest tube and pigtail order：
    - Drainage rate < 200cc/ 2hrs 及< 1500cc/day。
    - 注意 pulmonary re-expansion 的症狀：cough、chest pain、cold sweating、hypotension、pink frothy sputum。以及時 clamp chest tube。
    - Chest tube wound CD：QD and prn for effusion；QOD or Q3D for pneumothorax。
    - Pleurodesis of malignant effusion: OK-432 10 K.E. in normal saline 100mL。是否要 change position q15 minutes，請依主治醫師習慣。施打之前請知會病房 CR, 有發生 anaphylactic shock 之風險
12. Chest echo and bronchoscopy：
    - Bronchoscopy 除住院通知上 order，需主治醫師或 CR 同意。請家屬填寫同意書。
    - Bronchoscopy 檢查於 11 樓支鏡室，Chest echo 檢查於一樓胸超檢查室。
    - Chest echo 需 sign permit 但不用 NPO 四小時，需家屬陪同。若預定要做 biopsy，請讓病人帶沙袋。
    - Bronchoscopy 至少需要 NPO 四小時，早上排程可前一晚 midnight NPO，下午排程可早餐儘早吃過後 NPO。
    - 做 bronchoscope 病人請至少有 IV Lock，最好有 IVF (keep open)。
    - 請於檢查單上或 progress note 上說明安排檢查的原因與要做的細項。
    - 病人回病房若有 acute respiratory distress，請通知 CR 及照 CXR。
13. Chemotherapy
    - 請務必確定 ANC(segment+band)及 platelet 足夠再開始。
    - 於胸腔科開立化療處置單 intravenous chemotherapy 4-8 hours。

- 請務必確定病人接受之 regimen 及劑量，有疑問請詢問 CR 或主治醫師。出院請開立抽血單(依 regimen)，回診時間請配合 regimen。

- 15. EGFR/ALK/PDL1/ ROS1

  -醫囑開單因檢驗方式與計價常更動， 請參考每個月 CR 月初 orientation 發放的版本。

16. 胸腔科常用檢查：

甲、 Lung function test

- Screen spirometry：M21-037
- Screen spirometry + bronchodilator response：M21-038
- Provocation test：M25-112-1 and M21-056
- FRC/TLC：M21-023，Lung diffusion capacity：M21-028
- 全套(Spirometry + FRC/TLC + Lung diffusion capacity)：M21-056 + M21-023 + M21-028

乙、 Bronchoscopy

- Bronchoscopy, diagnostic：M21-011
- Procedure sedation：M21-211 (自費 5000 元)
- LIAF (laser image autofluorescent endoscopy)：M21-064
- EBUS (endobronchoscopic ultrasonography)：M21-078

- Chest echo
  - Chest echo gram：M21-051
  - Chest echo guided aspiration：M21-053
- Pleural biopsy
  - Pleural biopsy (echo guided): M21-002
  - Pleuroscope: M21-010 (morphine 1pc IVF)

17. 安寧流程(critical 病人請務必完成)：

甲、 末期病人診斷確認

- 路徑：住院醫囑→醫藥囑→末期病人→輸入→暫存 → Call VS or NP (67672/67670)

乙、 緩和醫療家庭諮詢

- 路徑：住院醫囑→病歷記載→緩和醫療家庭會議記錄(列印)→家屬簽名
- 路徑：住院醫囑→醫藥囑→輸入→全院處置→處置→G11-780

丙、 安寧共照啟動

- 開立醫囑：住院依囑→醫藥囑→處置→CONSULT 安寧共同照護
- 臨終關懷醫囑開立住院醫囑→醫藥囑→處置→ 臨終關懷